

Куджаев Вагаб Назирович

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА
ОБРАЩЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва – 2025

Диссертация выполнена на кафедре административного права и процесса имени Л.Л. Попова федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Научный руководитель: **Россинский Борис Вульфович**
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации

Официальные оппоненты: **Зырянов Сергей Михайлович**
доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник, федеральное
государственное научно-исследовательское
учреждение «Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»
Прилуков Максим Дмитриевич
кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры административного и финансового
права, федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им.
Н.И. Лобачевского»

Ведущая организация: **федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский
государственный университет»**

Защита состоится «12» мая 2026 года в 15:00 на заседании диссертационного совета 24.2.336.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», г. Москва, 123242, ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» <http://msal.ru>.

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор юридических наук, доцент

Ю.К. Цареградская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших направлений деятельности органов публичной власти по достижению стратегической цели современности – сбережение народа России выступает совершенствование системы здравоохранения, в том числе улучшение обеспечения населения качественными медицинскими изделиями.

Медицинские изделия являются одной из наиболее наукоемких отраслей российской промышленности. Уровень технологий, применяемых в отрасли производства медицинских изделий, сравним с уровнем технологий военного назначения. В этой связи невозможно переоценить значимость развития предприятий по производству медицинских изделий для успешной реализации научного и инновационного потенциала Российской Федерации¹.

В настоящее время рынок медицинских изделий – один из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. Это обусловлено резким увеличением к настоящему времени количества государственных и муниципальных закупок медицинских изделий и лекарств – до 1,21 млн сделок (ежегодный рост составляет 7%). Совокупный объем процедур по приобретению не только препаратов и реагентов, но и медицинской техники и сопутствующих инструментов за период с 2023 по 2024 годы вырос на 26,8% и в денежном выражении достиг 2,27 трлн руб.².

В 2024 году по сравнению с предыдущим объем рынка медицинских изделий вырос на 14 процентов и достиг 850 миллиардов рублей³. Постепенно наращивается производство отечественных медицинских изделий. Вместе с тем в 2023 году лишь 23% оборудования и изделий,

¹ См.: Колосов И.Е. Разработка инструментария формирования инновационной среды предприятий по производству медицинских изделий / Дисс... канд. экон. наук. – Н. Новгород, 2012. С. 3-4.

² См.: Рынок медицинского оборудования и изделий 2024 – аналитические материалы // <https://zdrav.expert/index.php> (дата обращения: 20.07.2025).

³ Батенева Т. Отечественные медицинские изделия приходят на смену западным// <https://rg.ru/2025/06/20/v-chetyre-ruki.html?ysclid=mdgvl193ik818664075> (дата обращения: 10.07.2025).

необходимых отрасли здравоохранения, производилось внутри страны. Утраченное в 90-е годы прошлого столетия собственное производство лекарственных средств и медицинских изделий, вынуждало использовать импортную продукцию. В результате возникла катастрофическая разница между экспортом и импортом товаров медицинского назначения, высокая доля контрафактных, некачественных лекарств и медицинских изделий, напрямую угрожающих здоровью нации. Осложняет ситуацию и то обстоятельство, что вследствие высокой рентабельности в оптовой торговле медицинскими изделиями доминирует частный бизнес. Неоправданно большое количество оптовых коммерческих структур, работающих на рынке медицинских изделий, которые часто не имеют ни соответствующего опыта, ни квалифицированных специалистов, а также необходимых условий для обеспечения должного уровня производства, хранения и транспортировки, приводит к появлению в аптечной и торговой сети некачественных и небезопасных для потребителей медицинских изделий¹.

С целью минимизации для общества и государства перечисленных рисков чрезвычайно важно обеспечить надлежащий государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью медицинских изделий, что требует переосмысления теоретических и правовых основ контрольной и надзорной деятельности в данной сфере.

Актуальность теме исследования придает и проводимая в настоящее время реформа контрольно-надзорной деятельности. Правовую основу функционирования обновленной системы государственного контроля и надзора в Российской Федерации заложил Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»², а также

¹ Подробнее смотри: Куджаев В.Н. О борьбе с фальсифицированными медицинскими изделиями //Административное право и процесс. 2024. № 6.

² Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №19 ст. 2338.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее также Федеральный закон № 248-ФЗ)¹, в котором законодательно закреплены контуры новой модели осуществления контрольно-надзорной деятельности. Актуализирует тему исследования и то обстоятельство, что начиная с пандемии новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 потребовалось ускоренное импортозамещение определенных видов медицинских изделий, особую остроту этот процесс приобрел в условиях беспрецедентных экономических санкций.

Таким образом, актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования теоретических основ и адаптирования имеющейся нормативной правовой базы в сфере обращения медицинских изделий к потребностям развития рынка качественных, безопасных и эффективных медицинских изделий в интересах общества и государства.

Степень разработанности темы исследования. Проблема организации федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий имеет чрезвычайно сложное и разностороннее содержание. Ее различные аспекты активно исследуются представителями самых разных отраслей знания – социологии, экономики, права, менеджмента, теории государственного и социального управления и других наук.

Большое внимание вопросам правовой природы государственного контроля и надзора, определению их места и роли в деятельности органов исполнительной власти уделено в работах российских правоведов: Д.Н. Бахраха, А.В. Васильева, С.Л. Денисова, Б.П. Елисеева, А.В. Ерицяна, С.М. Зубарева, С.М. Зырянова, Д.А. Ковачева, Ю.М. Козлова, В.О. Лучина, А.В. Мартынова, В.С. Основина, М.И. Пискотина, Н.Д. Погосяна, М.Д.

¹ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 31 (часть 1) ст. 5007.

Прилукова, В.С. Прониной, Б.В. Россинского, А.Д. Селюкова, М.Л. Слепцова, Ю.Н. Старилова, М.С. Студеникиной, В.Е. Чиркина, И.Б. Шахова, Е. В. Шориной, Ю.Л. Шульженко, Ц.А. Ямпольской и др.

Проблемы формирования и реализации правовых основ государственного контроля в сфере обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации освещаются в трудах таких ученых, как: С.В. Воронкова, Т.С. Гусева, Т.В. Ерохина, О.В. Назаров, Ю.Д. Сергеев, Д.П. Карпова, В.Т. Карташов, И.Е. Колосов, С.Б. Кузьмин, М.А. Мигеева, С.С. Тихонова, М.А. Шишов, Т.О. Шилук и др.

Отдельные виды и формы осуществления органами государственной власти контрольной деятельности были рассмотрены в трудах Г.В. Барабашева, В.В. Бурцева, Р.Ф. Васильева, Н.В. Витрука, В.Г. Вишнякова, А.А. Демина, Б.Н. Габричидзе, К.Ф. Гуценко, Н.М. Казанцева, Н.Г. Кобеца, Л.М. Колодкина, В.В. Корченова, Н.В. Котелевской, Е.Н. Кочерина, Д.М. Овсянко, И.И. Овчинникова, В.А. Прокошина, Б.А. Страшуна, С.В. Степашина, А.М. Тарасова, Ю.А. Тихомирова, Н.Ю. Хаманевой, И.Д. Хутинаева, М.С. Шалумова, В.С. Четверикова и др.

Объектом диссертационного исследования выступают совокупность общественных отношений, возникающих в процессе осуществления федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий.

Предметом исследования являются теоретические воззрения, взгляды ученых относительно государственного контроля и надзора, в том числе за обращением медицинских изделий; нормы, регулирующие организацию и осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения медицинских изделий, а также практика осуществления этой деятельности.

Целью диссертационной работы является разработка теоретических аспектов, правового и организационного обеспечения осуществления

федерального государственного контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий и подготовка на этой основе научно-обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в данной сфере.

Достижению указанной цели способствовало решение следующих задач:

- определение понятия и сущности федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий;
- исследование обращения медицинских изделий как объекта федерального государственного контроля и надзора;
- рассмотрение риск-ориентированного подхода как базового метода организации и осуществления федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий;
- исследование правовых основ федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий;
- определение мер административного принуждения, применяемых при осуществлении федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий;
- изучение организационных основ федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий.

Методологическая основа исследования. Для достижения поставленных задач использованы диалектический метод познания, теоретико-методологические аспекты государственного и публичного управления, отраслей знаний в сфере охраны здоровья населения.

В работе использовались как общенаучные методы (системный, структурно-функциональный, исторический, анализ, синтез, обобщение, сравнение), так и специальные методы – формально-юридический, нормативно-логический, ситуационный подход, статистический анализ, методы анкетирования и опроса, экспертных оценок, метод толкования

правовых норм и др.

Применение этих методов позволило исследовать государственный контроль и надзор за обращением медицинских изделий во взаимосвязях и взаимозависимостях, целостности и всесторонности, выявить некоторые тенденции их развития, сделать обобщения, сформировать предложения и рекомендации по совершенствованию федерального государственного контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации.

Теоретической базой диссертационного исследования послужили произведения отечественных ученых-правоведов, в частности: С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, А.И. Бобылева, Н.И. Матузова, В.С. Нерсисянца, В.Д. Перевалова, В.М. Сырых, Ф.М. Раянова, А.Н. Тимонина, М.М. Утяшева и др.; работы по конституционному праву С.А. Авакьяна, Е.Н. Козловой, О.Е. Кутафина, Н.А. Михалевой, В.К. Самигуллина; труды советских и российских административистов Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, Р.Ф. Васильева, В.Г. Вишнякова, В.М. Горшенева, С.М. Зубарева, С.М. Зырянова, Ю.М. Козлова, А. В. Мартынова, А.Ф. Ноздрачева, Д.М. Овсянко, Г.И. Петрова, Н.И. Побежимовой, Л.Л. Попова, М.Д. Прилукова, В.С. Прониной, Б.В. Россинского, Н.Г. Салищевой, М.С. Студеникиной, Ю.А. Тихомирова, Е.В. Шориной, И.Б. Шахова. Теоретические положения и выводы, содержащиеся в работах перечисленных ученых, позволили выработать основные концептуальные идеи о сущности федерального государственного контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий, исследовать правовые механизмы их осуществления уполномоченными органами исполнительной власти, обосновать предложения по совершенствованию правового регулирования и практики контрольно-надзорной деятельности.

Нормативная основа исследования. Выводы исследования базируются на положениях Конституции Российской Федерации,

федеральных конституционных законах, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, регламентирующих организацию и осуществление государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили информационно-аналитические материалы о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор) за период с 2004 по 2025 годы, статистические данные о состоянии и динамике обращения медицинских изделий за 2014-2025 годы. Изучены более 300 материалов контрольно-надзорных мероприятий, 112 дел об административных правонарушениях в сфере обращения медицинских изделий, результаты анализа экспертных оценок 53 респондентов из числа государственных гражданских служащих и юристов, специалистов, работающих в сфере обращения медицинских изделий, а также многолетний опыт практической работы автора в сфере контроля и надзора за обращением медицинских изделий.

Научная новизна работы заключается в том, что в диссертации, которая является комплексным монографическим исследованием проблем федерального государственного контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий в условиях реформирования системы здравоохранения, данные вопросы рассмотрены с системных позиций. Автором уточнено понятие федерального государственного контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации, обосновано разграничение функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти по осуществлению государственного контроля и государственного (административного) надзора за обращением медицинских изделий.

Научная новизна исследования отражена в полученных результатах,

позволивших, во-первых, определить правовую природу контрольной и надзорной деятельности в сфере обращения медицинских изделий, показать влияние объекта контроля и надзора на организацию и функционирование уполномоченных федеральных органов исполнительной власти; во-вторых, обосновать риск-ориентированный подход в качестве методологической основы осуществления современной контрольно-надзорной деятельности в рассматриваемой области; в-третьих, выявить проблемы в правовом регулировании и проведении контрольно-надзорных мероприятий за обращением медицинских изделий, а также предложить пути их преодоления.

Положения, выносимые на защиту:

1. Особенности федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий определяются тем обстоятельством, что обращение медицинских изделий включает в себя широкий круг принципиально разных составляющих его элементов технического, транспортного, клинико-испытательного, эксплуатационного, биоэнергетического, информационного и иного характера. К ним относятся различные процессы, начиная от разработки медицинского изделия, проведение всех необходимых испытаний, государственная регистрация изделия, его эксплуатация и, заканчивая утилизацией. При этом подавляющее большинство перечисленных элементов существенно отличаются установленными для них законодательством обязательными требованиями.

2. Определено, что, несмотря на фактическое отождествление государственного контроля и надзора в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», федеральный государственный контроль за обращением медицинских изделий и надзор в этой сфере отличаются друг от друга, имеют определенную специфику, являются самостоятельными формами управленческого воздействия. Федеральный надзор, который осуществляется только Росздравнадзором, реализующим надзорные

полномочия в отношении любого элемента системы здравоохранения независимо от ее формы собственности (в части проверки исполнения медицинскими организациями установленных обязательных требований в сфере обращения медицинских изделий), будучи функцией управления, имеет в то же время ярко выраженную правоохранительную природу. Государственный контроль в сфере обращения медицинских изделий, который осуществляется федеральными органами исполнительной власти в отношении подведомственных им организаций, а также – другими субъектами государственного контроля, обладая значительными проверочными полномочиями, имеет лишь общую управленческую природу.

3. Правовую основу федерального государственного контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий составляют общие нормы, содержащиеся в федеральных законах и постановлениях Правительства Российской Федерации, и специальные нормы, регулирующие осуществление ведомственного контроля и содержащиеся в ведомственных подзаконных актах. Однако определено, что в подзаконном регулировании ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в том числе соблюдения обязательных требований к обращению медицинских изделий, существуют пробелы и коллизии, связанные с отсутствием на ведомственном уровне регламентации правил проверки соблюдения требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий, а также их утилизации. В этой связи нормативного закрепления данной функции и полномочий по ее осуществлению в статутных положениях о федеральных органах исполнительной власти, в ведении которых находятся медицинские организации, недостаточно. Этими органами должны быть приняты также ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях, которые включали бы правила проверки соблюдения требований по

безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации.

4. Доказано, что среди контрольно-надзорных мероприятий, реализуемых в рамках федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий, наиболее действенными являются выездная проверка и выборочный контроль. Однако в процессе их осуществления применяется также наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), которое нельзя относить к контрольно-надзорным мероприятиям, предусмотренным Положением о контроле и надзоре за обращением медицинских изделий, утвержденным соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации. Мониторинг осуществляется на всех этапах обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации и, по сути, представляет собой комплекс профилактических мероприятий, реализуемых вне рамок государственного контроля и надзора, так как они имеют иные цели и правовые основы. Его проведение должно регулироваться специальным постановлением Правительства Российской Федерации.

5. Совокупность мер административного принуждения, применяемых в сфере обращения медицинских изделий, необходимо рассматривать не изолированно друг от друга, а как стадии единой административно-надзорной и административно-наказательной деятельности. Показано, что административно-предупредительные меры в сфере обращения медицинских изделий имеют свои особенности и выражаются в форме профилактических мероприятий, таких как предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, объявление предостережения, профилактический визит, мониторинг безопасности.

В качестве административно-пресекательной меры при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан либо причинении такого вреда Росздравнадзор принимает решение о приостановлении применения

медицинского изделия и осуществляет отбор образцов медицинских изделий, серии/партии которого вызвали неблагоприятные последствия либо создали реальную угрозу их наступления. Однако Росздравнадзор не обладает полномочиями по изъятию из оборота незарегистрированных медицинских изделий, что значительно снижает эффективность надзорных мероприятий. В связи с этим необходимо нормативно закрепить полномочия Росздравнадзора по признанию медицинских изделий незарегистрированными, изъятию их из оборота и принятию соответствующего регуляторного воздействия.

6. Эффективность контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора неразрывно связана с привлечением виновных лиц к административной ответственности за нарушение порядка обращения медицинских изделий. В целях полного исполнения результатов государственного контроля и надзора предлагается дополнить диспозицию частей 2 и 3 ст. 6.33 КоАП РФ обязательным признаком «реализация незарегистрированного медицинского изделия». Учитывая социальную опасность обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, целесообразно в санкциях статей 6.28 и 6.33 КоАП РФ предусмотреть конфискацию предмета административного правонарушения в качестве как основного, так и дополнительного административного наказания.

7. Организационные основы федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий представляют собой совокупность форм и способов упорядочения контрольной и надзорной деятельности, имеющих целью создание и функционирование системы контроля и надзора, способной обеспечить безопасный и эффективный оборот медицинских изделий. С одной стороны, это процесс формирования и совершенствования уполномоченных органов государственного контроля и надзора и их должностных лиц, с другой – это система функционирования этих органов и должностных лиц, обеспечивающая целенаправленное и действенное осуществление контрольной и надзорной деятельности, четкое

организационное взаимодействие между различными субъектами ее осуществляющими.

При этом первостепенное значение для повышения уровня организации федерального государственного контроля и надзора имеет установление четких организационных отношений между субъектами контроля и надзора, прежде всего иерархических и координационных связей, а также организация взаимодействия как между самими субъектами контроля и надзора, так и между ними и иными заинтересованными органами и организациями. В современных условиях центральное место в организации подобного взаимодействия занимает информационное обеспечение, в целях совершенствования которого необходимо обеспечить координацию АИС Росздравнадзора и информационных систем иных органов исполнительной власти, осуществляющих функции контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий.

8. Установлено, что при организации и осуществлении федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий основной упор делается на риск-ориентированный подход. Между тем, утвержденные в настоящее время индикаторы риска нарушения обязательных требований в сфере обращения медицинских изделий не соответствуют таким критериям, как научная обоснованность, формальная определенность и доступность для надзорного органа. Исходя из того, что медицинские изделия подразделяются на виды и классы в зависимости от потенциального риска их применения, включают в себя изделия медицинского назначения и медицинскую технику, а также в целях организации контрольной и надзорной деятельности на основе системы управления рисками Росздравнадзору необходимо:

- совместно с ассоциациями производителей медицинских изделий пересмотреть систему классификации объектов государственного контроля и надзора, предусмотрев в ней новые критерии отнесения к определенным

категориям риска. В частности, основанием для понижения категории риска может стать внедрение и поддержание производителем медицинских изделий системы менеджмента качества на производстве;

- применять в процессе осуществления контрольно-надзорных мероприятий различные режимы контроля и надзора в зависимости от класса опасности того или иного объекта контроля (дифференцированная периодичность проведения плановых проверок, отсутствие проведения плановых проверок в отношении наименее опасных объектов контроля и т.д.);

- разработать и внедрить информационную систему управления рисками потенциальной опасности видов медицинской и фармацевтической деятельности и использование ее при планировании контрольных и надзорных мероприятий;

- организовать взаимодействие информационной системы управления рисками потенциальной опасности видов медицинской и фармацевтической деятельности и создаваемой единой системой регистрации случаев причинения вреда в сферах государственного контроля и надзора.

9. Проведённые в диссертации исследования позволили разработать предложения по совершенствованию правового регулирования федерального государственного контроля и надзора, связанные с необходимостью:

- подготовки и принятия федерального закона «Об обращении медицинских изделий», в котором отдельную главу следует посвятить организации и осуществлению государственного контроля и надзора;

- внесения изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части 3 статьи 38 после слов «в том числе техническое обслуживание» дополнить словами «и программное обеспечение систем» и далее по тексту;

- принятия постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующего порядок проведения мониторинга безопасности обращения медицинских изделий;

- введения в Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий, утвержденного приказом Минздрава России от 17 июля 2023 г. № 368н, новых индикаторов, связанных с нормативно-правовым регулированием контрольных и надзорных мероприятий в сфере обращения медицинских изделий, с целью обеспечения безопасности медицинской деятельности, мониторинга безопасности и лицензирования деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий;

- включения в Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере обращения медицинских изделий, утвержденное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 14 ноября 2022 г., направления «Программное обеспечение медицинских изделий» для системы первичной биоэнергетической диагностики, информационной системы экстренной медицинской помощи, информационной системы клинической лаборатории, информационной системы управления рисками.

Редакции соответствующих предложений содержатся в тексте диссертации.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования непосредственно связана с элементами научной новизны. Сформулированы теоретические положения, составляющие концептуальные основы современного федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий, предложены методологические подходы к формированию частной теории контрольно-надзорной деятельности полномочных органов Росздравнадзора. Теоретические выводы, полученные автором, способствуют расширению и углублению имеющихся в современной науке представлений о средствах и способах контрольно-надзорного воздействия, путях достижения целей контроля и надзора посредством

использования административного и функционального потенциала ее субъектов, что позволяет рассматривать как вклад в развитие науки административного права.

Практическая значимость исследования вытекает из актуальности диссертации и состоит в разработке обоснованных предложений и рекомендаций, позволяющих оптимизировать контрольно-надзорную деятельность и, следовательно, обеспечить безопасность и охрану здоровья граждан. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке концепции федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий, федерального закона об обращении медицинских изделий, совершенствовании действующего законодательства и практики его применения в сфере обращения медицинских изделий. Положения диссертации расширяют теоретико-методологическую основу для дальнейшего проведения дополнительных исследований в данном направлении и могут быть использованы в процессе преподавания курса медицинского права, основанных на нем спецкурсов и семинаров.

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования определяется использованием методологии комплексного подхода и системного анализа к исследованию вопросов административного воздействия и средств достижения целей федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий. Для обеспечения комплексности изучения проблемы частной теории контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности и охраны здоровья граждан, использован широкий круг источников, составляющих теоретическую, методологическую и нормативно-правовую базу исследования.

Выводы исследования основываются на: анализе законодательства в области здравоохранения, статистических и фактографических данных о состоянии государственного контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий; результатах социологического исследования,

проведенного автором по проблемам организации и осуществления контрольной и надзорной деятельности в рассматриваемой сфере; а также личном практическом опыте соискателя в организационно-управленческой и правоприменительной деятельности в данной сфере.

Апробация и внедрение результатов исследования. Учитывая комплексный и теоретико-прикладной характер проведенного исследования, его апробация и внедрение осуществлялись по многим направлениям.

Основные положения и результаты диссертации докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях: II ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Образование и наука: вопросы теории и практики» (г. Москва, 8 февраля 2016 г., МИИГУ им. П.А. Столыпина); Всемирном Дне безопасности пациентов в 2022 году – «Безопасное применение лекарственных препаратов под девизом: «Лекарства без вреда!» (Москва, 17 сентября 2022 года); II, III, IV, V Всероссийском форуме с международным участием «Обращение медицинских изделий «NOVAMED» (Москва, 10-11 ноября 2022 года, 8-9 ноября 2023 года, 14-15 ноября 2024 года, 10-11 ноября 2025 года); XV Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество» (7-8 декабря 2022 года), XXIV ежегодной Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий «Фарммедобращение 2022» (17-18 октября 2022 года); международной научно-практической конференции «Система административного права в условиях новых вызовов» в рамках XXIII Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» XIV Московской юридической недели (Москва, 28.11.2024 г.).

Основные положения и результаты диссертации отражены в 10 публикациях общим объёмом 5,7 п.л., в том числе в 7 статьях в научных изданиях, включённых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в перечень

рецензируемых изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций.

На основании материалов диссертационного исследования автором подготовлены методические рекомендации, содержащие предложения, направленные на существенное улучшение организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности за обращением медицинских изделий в органах здравоохранения г. Москвы и Московской области.

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертационного исследования обосновывается актуальность, разработанность темы, выделяется объект, предмет, цель, задачи исследования, методологическая, теоретическая и эмпирическая база, аргументирована его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов и формулируются положения, выносимые на защиту.

Глава 1 **«Теоретические основы федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий»** состоит из трех параграфов.

Первый параграф *«Понятие и сущность федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий»* посвящен комплексному анализу существующих подходов к организации федерального государственного контроля и надзора, выявлению сущностных признаков контрольной и надзорной деятельности и раскрытию содержания исследуемых категорий.

На основе анализа теоретических положений о характере государственного контроля и надзора и практики их применения в сфере обращения медицинских изделий контроль и надзор определяются как функции управления и как государственно-правовые институты. В свою очередь в параграфе показано, что федеральный государственный контроль и надзор за обращением медицинских изделий, следует рассматривать комплексно, с одной стороны, как систему мер, направленных на обеспечение соблюдения и исполнения требований законодательства, регламентирующего качество и безопасность медицинской деятельности в части обращения медицинских изделий (вид контроля), с другой – как систему мер по предупреждению, пресечению и устранению нарушений в сфере оборота медицинских изделий (вид надзора). Установлено также, что сущность федерального государственного контроля и надзора в сфере обращения

медицинских изделий характеризуется единством их правовой природы, взаимосвязями между целями, задачами и формами их достижения.

При этом контроль и надзор имеют определенную специфику как самостоятельные формы управленческого воздействия. Утверждается, что, несмотря на фактическое отождествление государственного контроля и надзора в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», федеральный государственный контроль за обращением медицинских изделий и надзор в этой сфере отличаются друг от друга, имеют определенную специфику, являются самостоятельными формами управленческого воздействия.

Показано, что государственный ведомственный контроль доминирует в государственной системе здравоохранения. На федеральном уровне он осуществляется федеральными органами исполнительной власти в отношении подведомственных им медицинских организаций. Ведомственный контроль обладает основными признаками контрольной деятельности: 1) осуществляется в порядке ведомственной подчиненности; 2) субъектами контроля являются должностные лица вышестоящего органа исполнительной власти; 3) предмет контроля охватывает не только соблюдение требований в сфере обращения медицинских изделий, но и иные вопросы; 4) основными формами контрольной деятельности являются плановые и внеплановые проверки, однако это не исключает использование иных форм контроля; 5) по итогам проверки принимаются меры организационного или дисциплинарного характера. Министерство здравоохранения Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти осуществляют контроль за обращением медицинских изделий в медицинских организациях, находящихся в их ведении, в рамках контроля качества и безопасности медицинской деятельности в виде ведомственного контроля.

В параграфе отмечается, что федеральный государственный контроль

(надзор) во многом обладает признаками административного надзора. В сфере обращения медицинских изделий его реализует Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, наделенная для этого надзорными полномочиями в отношении любого элемента системы здравоохранения (государственной, муниципальной или частной), независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, но только в части проверки исполнения установленных обязательных требований. В отличие от ведомственного контроля организация и осуществление федерального государственного контроля за обращением медицинских изделий регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее также Закон об основах охраны здоровья). Согласно п. 4 ст. 85 последнего Закона федеральный государственный контроль (надзор) за обращением медицинских изделий выступает неотъемлемой частью контроля (надзора) в сфере охраны здоровья.

Предметом контроля (надзора) выступает соблюдение обязательных требований к обращению медицинских изделий. Формы контрольных (надзорных) мероприятий и порядок их осуществления четко определены в Федеральном законе № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», т.к. при их проведении возможны ограничения прав и свобод контролируемых лиц. Должностные лица при осуществлении контроля (надзора) наделены правом применения мер административного принуждения, а по его итогам могут привлечь виновных к административной ответственности.

Отмечается, что объект, предмет и формы контроля (надзора) конкретизированы в Положении о федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий, которое утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1066 – далее также Положение о контроле (надзоре).

Во втором параграфе *«Обращение медицинских изделий как объект федерального государственного контроля и надзора»* автором уточнено содержание понятий «медицинские изделия» и «обращение медицинских изделий». Для целей настоящего исследования предложено под медицинскими изделиями понимать любые зарегистрированные инструменты, аппараты, приборы, устройства, программное обеспечение, материалы или иные изделия, используемые по отдельности или в сочетании между собой, необходимые для их применения по назначению, которые предназначены производителем для применения к человеку с целью диагностики, профилактики, наблюдения, лечения или облегчения заболевания, наблюдения, или компенсации травмы или инвалидности, обращение которых подлежат обязательному мониторингу в рамках федерального государственного контроля и надзора. Обосновано, что необходимо отнесение программного обеспечения к медицинским изделиям, в том случае если оно является «помощником» для работников медицинских организаций для диагностирования и обнаружения заболеваний, мониторинга состояния здоровья пациентов, прогнозирования физиологического состояния человека. В связи с этим предложено внести соответствующие изменения в часть 3 статьи 38 Закона об основах охраны здоровья граждан.

В диссертации проанализированы различные основания классификации медицинских изделий, сделан вывод, при организации и осуществлении федерального государственного контроля и надзора имеет значение отнесение медицинского изделия только к одному классу. Отнесение медицинских изделий к классам осуществляется, исходя из следующего: к классу 1 относятся медицинские изделия с низкой степенью потенциального риска применения; к классу 2а относятся медицинские изделия со средней степенью потенциального риска применения; к классу 2б относятся медицинские

изделия с повышенной степенью потенциального риска применения; к классу 3 относятся медицинские изделия с высокой степенью потенциального риска применения.

Обращение медицинских изделий выступает объектом федерального государственного контроля и надзора на всем протяжении их жизненного цикла, включающего в себя технические испытания, токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание и программное обеспечение для системы первичной биоэнергетической диагностики, информационной системы экстренной медицинской помощи, информационной системы клинической лаборатории, информационной системы управления рисками, предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя), а также ремонт, утилизацию или уничтожение.

Тем самым особенности федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий определяются тем обстоятельством, что обращение медицинских изделий включает в себя широкий круг принципиально разных составляющих его элементов технического, транспортного, клинико-испытательного, эксплуатационного, биоэнергетического, информационного и иного характера. К ним относятся различные процессы, начиная от разработки медицинского изделия, проведение всех необходимых испытаний, государственная регистрация изделия, его эксплуатация и, заканчивая утилизацией. При этом подавляющее большинство перечисленных элементов существенно отличаются установленными для них законодательством обязательными требованиями,

которые в свою очередь выступают предметом государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий.

В третьем параграфе *«Риск-ориентированный подход при организации и осуществлении федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий»* на основе анализа действующих нормативных правовых актов и имеющихся теоретических положений, а также обобщения практики осуществления федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий рассмотрена сущность риск-ориентированного подхода. Определено, что в исследуемой сфере этот подход позволяет осуществлять различную по объему и периодичности надзорную деятельность в отношении поднадзорных объектов в зависимости от степени их потенциальной опасности.

В диссертации показаны особенности применения риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий. Проанализированы поднадзорные объекты в зависимости от присвоенной категории риска, особое внимание уделено порядку установления индикаторов риска. Работа по индикаторам риска позволяет Росздравнадзору активизировать деятельность по организации проведения внеплановых проверок, а также в части определения того, что фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия подлежат уничтожению или вывозу с территории Российской Федерации, а контрафактные - изъятию из обращения и последующему уничтожению.

Установлено наличие причинно-следственных связей управления рисками в сфере обращения медицинских изделий между:

научно-обоснованными и нормативно-регулируемыми прогнозами обращения медицинских изделий с учетом неблагоприятных обстоятельств, связанных с применением фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции;

индикаторами риска выпускаемых медицинских изделий и необратимыми последствиями нанесенного вреда здоровью граждан;

субъектом и объектом контроля (надзора), при наличии прямого (нормативно-закрепленного) доступа.

Сделан вывод, что утвержденные в настоящее время индикаторы риска нарушения обязательных требований в сфере обращения медицинских изделий не соответствуют таким критериям, как научная обоснованность, формальная определенность и доступность для надзорного органа. Поэтому в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности на основе системы управления рисками Росздравнадзору признано необходимым:

- совместно с ассоциациями производителей медицинских изделий пересмотреть систему классификации объектов государственного контроля и надзора, предусмотрев в ней новые критерии отнесения к определенным категориям риска. В частности, основанием для понижения категории риска может стать внедрение и поддержание производителем медицинских изделий системы менеджмента качества на производстве;

- применять в процессе осуществления контрольно-надзорных мероприятий различные режимы контроля и надзора в зависимости от класса опасности того или иного объекта контроля (дифференцированная периодичность проведения плановых проверок, отсутствие проведения плановых проверок в отношении наименее опасных объектов контроля и т.д.);

- разработать и внедрить информационную систему управления рисками потенциальной опасности видов медицинской и фармацевтической деятельности и использование ее при планировании контрольных и надзорных мероприятий;

- организовать взаимодействие информационной системы управления рисками потенциальной опасности видов медицинской и фармацевтической деятельности и создаваемой единой системой регистрации случаев причинения вреда в сферах государственного контроля и надзора.

Глава 2 «Правовые и организационные основы федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Правовые основы федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий» проанализированы нормативные источники, регулирующие деятельность уполномоченных органов по осуществлению федерального государственного контроля и надзора за обращением зарегистрированных (за некоторым исключением и незарегистрированных) медицинских изделий с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья граждан.

Обнаружено, что особенностью правовой основы федерального государственного контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий выступает наличие общих и специальных норм. При этом если ведомственный контроль в указанной сфере регулируется только ст. 89 Закона об основах охраны здоровья и принятыми в ее развитие подзаконными актами, то осуществление федерального государственного контроля (надзора) регламентируется как ст. 95 указанного закона, так и нормами Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и актов, конкретизирующих его положения, в частности Положением о контроле и надзоре за обращением медицинских изделий, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1066 (далее - Положение о контроле и надзоре).

Установлено, что правовое регулирование ведомственного контроля как качества и безопасности медицинской деятельности в целом, так и в его рамках безопасности медицинских изделий, является недостаточным. Анализ нормативной базы показал, что во многих федеральных органах исполнительной власти (Минздрав России, ФМБА, МВД России, ФСИН России, Росавиация, ФТС России и др.), имеющих подведомственные

медицинские организации, функция и полномочия по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности не содержатся в статутных положениях об этих органах.

Кроме того, возложенное на Росздравнадзор полномочие по контролю организации и осуществления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации на практике реализовано быть не может ввиду отсутствия соответствующей нормативной базы.

В целом проведенный анализ выявил пробелы и коллизии в правовом регулировании на подзаконном уровне ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в том числе соблюдения обязательных требований к обращению медицинских изделий. Поэтому сделан вывод о целесообразности нормативного закрепления не только данной функции и полномочий по ее осуществлению в статутных положениях о федеральных органах исполнительной власти, в ведении которых находятся медицинские организации, но и принятие этими органами соответствующих ведомственных нормативных правовых актов.

Федеральный государственный контроль (надзор) за обращением медицинских изделий согласно ч. 1 ст. 95 Закона об основах охраны здоровья осуществляет Росздравнадзор. В диссертации изучена практика проведения указанной федеральной службой контрольно-надзорных мероприятий, которые согласно Закону реализуются в рамках этого вида контроля (надзора): 1) документарной проверки; 2) выездной проверки; 3) выборочного контроля; 4) контрольной закупки; 5) инспекционного визита; 6) наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).

Результаты изучения правоприменительной практики показали, что среди перечисленных видов контрольно-надзорных мероприятий наиболее действенными являются выездная проверка и выборочный контроль. Однако

в рамках федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий применяется также наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), которое по своим целям нельзя относить к контрольно-надзорным мероприятиям, предусмотренным Положением о контроле и надзоре за обращением медицинских изделий.

В работе выявлено, что такой мониторинг осуществляется на всех этапах обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации и, он, по сути, представляет собой комплекс профилактических мероприятий, реализуемых вне рамок государственного контроля и надзора, так как они имеют иные цели и правовые основы.

Во втором параграфе *«Меры административного принуждения, применяемые при осуществлении федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий»* проанализирована административно-юрисдикционная деятельность должностных лиц Росздравнадзора. Изучение соответствующей правоприменительной практики позволило выявить особенности использования мер административного принуждения в сфере обращения медицинских изделий. Прежде всего установлена тесная взаимосвязь этих мер с контрольно-надзорными мероприятиями, их необходимо рассматривать не изолированно друг от друга, а как стадии единой административно-надзорной и административно-наказательной деятельности. При этом административно-предупредительные меры в сфере обращения медицинских изделий имеют свою специфику и выражаются в форме профилактических мероприятий, таких как предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, объявление предостережения, профилактический визит, мониторинг безопасности. Анализ практики применения перечисленных профилактических мероприятий позволил определить тенденцию к росту использования различных цифровых технологий, например, профилактический визит во многих случаях проводится посредством

использования видеоконференцсвязи.

Административно-пресекательные меры в сфере обращения медицинских изделий имеют целью принудительное прекращение противоправных действий. Основанием для применения административно-пресекательных мер является наличие совершенного нарушения юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем обязательных требований качества и безопасности медицинских изделий. В рамках административно-пресекательных мер должностные лица Роспотребнадзора не только выдают предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения или составляют протокол об административном правонарушении в случае наличия его признаков, но и изымают из обращения партии или серии недоброкачественного медицинского изделия, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, а также приостанавливают применение медицинского изделия в связи с подтверждением фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий. Однако Росздравнадзор не обладает полномочиями по изъятию из оборота незарегистрированных медицинских изделий, что значительно снижает эффективность надзорных мероприятий. В этой связи показана целесообразность нормативного закрепления полномочий Росздравнадзора по признанию медицинских изделий незарегистрированными, изъятию их из оборота и принятию соответствующего регуляторного воздействия.

В параграфе проанализирована практика применения мер административной ответственности в сфере обращения медицинских изделий. В целях полного исполнения результатов государственного контроля и надзора предлагается дополнить диспозицию частей 2 и 3 ст. 6.33 КоАП РФ обязательным признаком «реализация незарегистрированного медицинского изделия». Учитывая социальную опасность обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских

изделий, целесообразно в санкциях статей 6.28 и 6.33 КоАП РФ предусмотреть конфискацию предмета административного правонарушения в качестве как основного, так и дополнительного административного наказания.

В третьем параграфе *«Организационные основы федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий»* автором рассмотрена совокупность организационно-правовых форм и способов упорядочения и повышения эффективности контрольной и надзорной деятельности.

Организационные основы федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий представляют собой совокупность форм и способов упорядочения контрольной и надзорной деятельности, имеющих целью создание и функционирование системы контроля и надзора, способной обеспечить безопасный и эффективный оборот медицинских изделий. С одной стороны, это процесс формирования и совершенствования уполномоченных органов государственного контроля и надзора и их должностных лиц, с другой – это система функционирования этих органов и должностных лиц, обеспечивающая целенаправленное и действенное осуществление контрольной и надзорной деятельности, четкое организационное взаимодействие между различными субъектами ее осуществляющими.

Организация федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий представлена в разрезе линейно-функциональной организационной структуры, в которую включены как органы общей компетенции (Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации), так и органы, уполномоченные непосредственно осуществлять контрольную и надзорную деятельность. В параграфе рассмотрены спорные моменты в нормативном регулировании организации деятельности Минздрава России и Росздравнадзора. В частности, отдельное полномочие Минздрава России по организации и осуществлению

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях, включающее в себя проверку соблюдения требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации, в Положении о Минздраве России не закреплено.

Законодательно на Росздравнадзор возложен федеральный государственный контроль (надзор) за обращением медицинских изделий. Однако, в статутном Положении сказано только о государственном контроле, что требует согласования его норм с законодательными предписаниями.

Обосновано, что первостепенное значение для повышения уровня организации федерального государственного контроля и надзора имеет установление четких организационных отношений между субъектами контроля и надзора (Минздрав России и Росздравнадзор) посредством развития иерархических и координационных связей. Кроме того, необходима организация взаимодействия как между самими субъектами контроля и надзора, так и между ними и иными заинтересованными органами и организациями (прежде всего органами Прокуратуры Российской Федерации, МВД России и иными правоохранительными органами). В современных условиях центральное место в организации подобного взаимодействия занимает информационное обеспечение, в целях совершенствования которого необходимо обеспечить координацию АИС Росздравнадзора и информационных систем иных органов исполнительной власти, осуществляющих функции контроля и надзора в сфере обращения медицинских изделий.

В заключении формулируются основные научные выводы и предложения по совершенствованию правового регулирования, организации и осуществления федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий:

Основные положения диссертации отражены в 10 публикациях автора, общим объемом 5,7 п.л.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Куджаев В.Н. Особенности и направления совершенствования федерального государственного контроля и надзора за обращением медицинских изделий // Административное право и процесс. – 2025. – № 5. – С. 76-79. (0,49 п.л.).

2. Куджаев В.Н. О борьбе с фальсифицированными медицинскими изделиями // Административное право и процесс. – 2024. – № 6. – С. 66-68. (0,40 п.л.).

3. Куджаев В.Н. Анализ законодательства о государственном контроле за обращением медицинских изделий // Административное право и процесс. – 2024. – № 4. – С. 68-71. (0,34 п.л.)

4. Куджаев В.Н. Некоторые вопросы государственного контроля в сфере обращения медицинских изделий // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2024. – № 1. – С. 21-25. (0,48 п.л.).

5. Куджаев В.Н. Реализация административно-правовых функций органами государственного контроля за обращением медицинских изделий в России // Образование и право. – 2017. – № 2. – С. 138-149. (1,09 п.л.).

6. Куджаев В.Н. Органы государственного контроля над обращением медицинских изделий: особенности реализации административно-правовых функций // Образование и право. – 2016. – № 2. – С. 166-177. (1,1 п.л.).

7. Куджаев В.Н. Взаимодействие органов здравоохранения с органами государственного контроля над обращением медицинских изделий в России // Образование и право. – 2016. – № 2. – С. 106-112. (0,63 п.л.).

Научные публикации в иных изданиях:

8. *Куджаев В.Н.* Анализ законодательства Российской Федерации о государственном контроле за обращением медицинских изделий // Вестник Росздравнадзора. – 2022. – № 5. – С. 76-79. (0,36 п.л.).

9. *Куджаев В.Н.* Проведение федерального государственного контроля за обращением медицинских изделий в соответствии с новым законодательством // Вестник Росздравнадзора. – 2021. – № 3. – С. 21-25. (0,37 п.л.).

10. *Куджаев В.Н.* Цели и задачи государственного контроля в сфере обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации // Образование и право. – 2015. – № 11 (75). – С. 91-98. (0,45 п.л.).